基孔肯雅热诊疗方案
（2025 年版）

基孔肯雅热（Chikungunya fever，CHIK）是由基孔肯雅病毒（Chikungunya virus，CHIKV）感染引起，经伊蚊叮咬传播的急性传染病。临床以发热、关节痛、皮疹为主要特征。基孔肯雅热在全球热带和亚热带地区广泛流行，流行范围呈持续扩大趋势。我国伊蚊分布广泛，近年来已经发生多起境外输入病例导致的本地传播疫情。为进一步规范基孔肯雅热临床诊疗工作，在 2008 年发布的《基孔肯雅热诊断和治疗方案》基础上，结合国内外最新研究进展和诊疗经验，制定本诊疗方案。

一、病原学

基孔肯雅病毒属于披膜病毒科甲病毒属，病毒颗粒呈球形，有包膜，直径为 60～70nm，只有 1 个血清型。基因组为单股正链 RNA，长度约 11.8kb，内含单一可读框依次编码 4 种非结构蛋白和 5 种结构蛋白。根据病毒基因组遗传进化分析，分为 3 个基因型，分别为西非型、东-中-南非型和亚洲型，其中东-中-南非型病毒突变形成的印度洋分支（IOL）病毒株，更易于经白纹伊蚊叮咬传播。

基孔肯雅病毒对热敏感，56℃30 分钟可灭活；不耐酸，70%乙醇、1%次氯酸钠、脂溶剂、过氧乙酸、甲醛、戊二醛、酚类、碘伏和季铵盐化合物等消毒剂及紫外照射可灭活。

二、流行病学

（一）传染源。

基孔肯雅热急性期患者、隐性感染者和感染病毒的非人灵长类动物。大多数患者在发病当天至发病后 7 天内具有传染性。

（二）传播途径。

主要通过携带基孔肯雅病毒的伊蚊（主要为白纹伊蚊和埃及伊蚊）叮咬传播。可发生母婴传播。罕见情况下可经输血或接触患者血液传播。

（三）易感人群。

人群对基孔肯雅病毒普遍易感。人感染病毒后可获得持久免疫力。

（四）流行特征。

1952 年在坦桑尼亚首次发现基孔肯雅病毒，最初在非洲流行，之后不断扩散到东南亚、南亚、印度洋岛屿及美洲地区。截至 2025 年 6 月，全球已有 119 个国家和地区报告了基孔肯雅热的本地传播。我国白纹伊蚊分布范围广泛，适合病毒快速传播的蚊媒活跃期长，存在“输入性病例-本地传播流行”模式。2010-2019 年，我国发生 4 起基孔肯雅热境外

输入继发本地病例，其中 2010 年广东东莞、2019 年云南瑞丽发生聚集性疫情。2025 年 7 月，广东佛山发生境外输入继发聚集性疫情。

三、发病机制

基孔肯雅病毒经伊蚊叮咬侵入人体数日内形成病毒血症，发病后 3 天内是高病毒血症期，随后病毒载量下降，常于病后 5～7 天消失。病毒通过其包膜上的 E1、E2 蛋白与巨噬细胞、上皮细胞、内皮细胞、成纤维细胞等细胞上的受体结合，通过细胞内吞作用进入细胞，在细胞内复制。病毒可直接侵入关节，在关节内复制，也可直接感染人成骨细胞、滑膜、腱鞘、肌肉中的巨噬细胞和成纤维细胞，导致促炎细胞因子、趋化因子释放、白细胞募集、凝血因子与补体相关蛋白失调，造成成骨细胞功能受损、骨质破坏，并可引发全身性感染和多器官损伤。慢性关节炎发病机制未完全明确，可能与病毒驱动炎症反应及 T 细胞持续激活相关。

四、临床表现

潜伏期 1～12 天，常为 3～7 天。

（一）发热：急性起病，发热以中低热为主，部分患者可为高热，可伴畏寒、头痛、背痛、全身肌肉疼痛、畏光、恶心、呕吐等。热程多为 1～7 天。

（二）关节痛：为基孔肯雅热的显著特征，可为首发症状。初始为单个或两个关节疼痛，常在 24～48 小时内出现多个

关节疼痛，可呈对称性分布。主要累及远端小关节，如踝、指、腕和趾关节等，也可累及膝和肩等大关节。疼痛随运动加剧，关节僵硬，可影响活动。受累关节周围肿胀、压痛，少数大关节受累者可出现关节腔积液。

绝大多数患者的关节疼痛及僵硬状态在发病数天内恢复，部分患者关节疼痛和僵硬可超过 12 周，有的甚至持续 18 个月以上，个别患者遗留关节功能损害。

（三）皮疹：多数患者在发病后 2～5 天出现皮疹，常分布在躯干、四肢、手掌和足底，也可累及面部，为斑疹、丘疹或斑丘疹，疹间皮肤多正常，呈斑片状或弥漫性分布，部分伴有瘙痒。数天后消退，可伴轻微脱屑。

（四）其他：可出现恶心、呕吐、食欲减退、头痛和肌肉疼痛等非特异性症状。部分患者淋巴结肿大伴触痛，以颈部淋巴结肿大为主。部分患者出现结膜炎，少数出现虹膜睫状体炎、视网膜炎和葡萄膜炎等眼部表现。

儿童病例高热多见，发热持续 3～5 日，除了关节疼痛，皮疹较成人更多见，可见累及面部的斑片状或弥漫性斑丘疹、疱疹、褶烂样皮损等。新生儿感染多在出生后 3～7 日内出现临床表现，包括发热、喂养困难，皮疹更广泛，可见肢端瘀斑和水肿。

极少数出现严重并发症，如脑膜脑炎、脊髓炎、心肌炎、急性肝损害、急性肾损害等，出血性并发症发生率极低。

五、实验室检查

（一）一般检查。

1.血常规：白细胞计数多正常，部分患者可见淋巴细胞和血小板轻度减少，新生儿感染血小板减少较常见。

2.生化检查：部分患者血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、肌酸激酶（CK）可升高。

3.脑脊液检查：并发脑膜脑炎时脑脊液检查符合病毒性脑炎改变。

（二）病原学和血清学检查。

1.核酸检测：采用实时荧光 PCR 或等温扩增核酸检测等方法检测血液样本中的基孔肯雅病毒核酸。

2.病毒分离：采用 Vero、C6/36、BHK-21 和 HeLa 等敏感细胞进行病毒分离。

3.血清抗体检测：采用 ELISA、免疫层析等方法检测血清特异性 IgM 和 IgG 抗体。IgM 抗体于发病 3～4 天可检出，5 天后阳性率增高，可持续数周至数月，因 IgM 抗体在潜伏期和发病早期阳性率低，阴性不能排除感染。IgG 抗体于发病后第 5～8 天可检出，可持续数年。

（三）影像学检查。

可见关节滑膜炎、关节肿胀、关节腔积液、腱鞘炎等改变。

六、诊断

根据流行病学史、临床表现及实验室检查结果，综合分析作出诊断。

（一）疑似病例。

发病前 12 天内，曾到过基孔肯雅热流行区或居住、工作场所周围曾有本病发生；且有上述临床表现（如发热、关节痛或皮疹等）者。

（二）临床诊断病例。

疑似病例，且血清特异性 IgM 抗体阳性者。

（三）确诊病例。

疑似病例或临床诊断病例，具有以下任一项者：

1.基孔肯雅病毒核酸阳性；

2.临床标本培养分离到基孔肯雅病毒；

3.血清基孔肯雅病毒 IgG 抗体阳转或恢复期较急性期抗体滴度呈 4 倍及以上升高。

七、鉴别诊断

主要与以发热、关节痛或皮疹为主要临床表现的相关疾病鉴别，关节疼痛和僵硬持续时间长者要与其他慢性关节炎鉴别。

（一）登革热。

登革热与基孔肯雅热的传播媒介相同，流行区域基本相同，临床表现类似，较难鉴别，且可存在合并感染的情况。登革热发热多为中高热，持续时间更长，肌肉痛、腹部症状

（腹痛、腹胀、便秘等）更明显，有出血倾向，外周血白细胞和血小板减少明显，红细胞压积、ALT 或 AST 常增高，重症较基孔肯雅热多见，可出现休克、脑病、多器官功能障碍等并发症。而基孔肯雅热多为中低热，关节疼痛明显，可为首发症状，多累及远端小关节，外周血白细胞、血小板基本正常，重症少见。需核酸检测鉴别。在登革热流行高风险区，建议也对登革热进行检测。

（二）寨卡病毒病。

寨卡病毒病与基孔肯雅热的传播媒介相同，流行区域基本相同，临床表现类似，亦表现为中低热，可伴皮疹、头痛、关节痛、肌痛和结膜炎，孕妇感染可引起胎儿小头畸形。基孔肯雅热关节痛更明显。需核酸检测鉴别。

（三）传染性红斑。

由细小病毒 B19 感染引起。儿童感染可表现为持续中高热，常合并皮疹，皮疹为多形性、多部位分布，典型表现为面颊部红斑样皮疹伴有口周苍白圈，称之为“掌击脸”，也可出现受累关节部位红斑、关节痛，常见外周血红细胞下降。核酸及病毒抗体检测有助于鉴别诊断。

（四）其他。

本病还需与疟疾、其他甲病毒感染、流感、麻疹、风疹、传染性单核细胞增多症、风湿热、反应性关节炎、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病相鉴别。

八、重症病例、重症高危人群和重症预警指标

本病重症少见，但境外基孔肯雅热疫情暴发时有重症及死亡病例报告，要加强病情监测，警惕重症病例发生。

（一）重症病例。

重症病例至少有一个器官或系统出现功能障碍，常见以下系统受累：

1.神经系统受累：脑膜脑炎、吉兰-巴雷综合征、脊髓炎等；

2.心脏受累：心肌炎、恶性心律失常、心源性休克等；

3.急性肝损伤：血清 ALT 或 AST＞1000IU/L 或总胆红素＞85.5μmol/L；

4.出凝血障碍：皮下血肿、便血等出血和弥漫性血管内凝血（DIC）等。

（二）重症高危人群。

1.婴儿；

2.老年人（65 岁以上）；

3.晚期妊娠和围产期妇女；

4.慢性基础疾病患者；

5.免疫抑制者（器官移植、AIDS、长期使用免疫抑制剂等）。

（三）重症预警指标。

1.持续高热或退热后病情加重；

2.神经系统症状：剧烈头痛、烦躁不安、嗜睡等；

3.心血管系统症状：心悸、胸闷、胸痛、心律失常、四肢厥冷、尿量减少等；

4.呼吸系统症状：呼吸急促、呼吸困难等；

5.出血表现：皮肤瘀斑、黏膜出血、黑便等。

九、治疗

目前尚无特异性治疗方法，以对症支持治疗为主。

（一）一般治疗。

1.关节疼痛明显者，建议卧床休息，受损关节应制动，避免负重和剧烈运动（如爬山、长跑等），防止加重关节损伤。

2.监测神志、生命体征、尿量、血小板、电解质、肝功能、出凝血功能等重症预警指标，及时处置，有基础疾病者要积极治疗原发病。

3.避免盲目使用抗菌药物。

4.不推荐使用糖皮质激素和免疫球蛋白。因原发病正在接受糖皮质激素和免疫球蛋白治疗的患者，根据原发病诊治需要和预期风险及获益权衡决定。

（二）对症治疗。

1.退热：以物理降温为主。高热不退者推荐使用对乙酰氨基酚，应避免使用阿司匹林等非甾体类抗炎药（NSAIDs）。有因基础疾病在服用阿司匹林的患者，应评估出血风险，决定是否停用或换用其他替代药物。儿童使用水杨酸类药物有引发 Reye 综合征风险，应避免使用。

2.镇痛：

（1）急性期关节疼痛不能忍受者，可使用对乙酰氨基酚。对乙酰氨基酚应以必需的最低剂量和最短疗程使用为原则，避免用于有肝病或转氨酶升高等禁忌证的患者。

（2）急性期过后关节仍疼痛者可使用局部外用贴剂，也可考虑红外线等物理治疗。

3.止痒：皮肤瘙痒者可予抗组胺药物口服或炉甘石洗剂外用。

（三）重症治疗。

1.神经系统。

脑水肿可予甘露醇或利尿剂等脱水治疗；癫痫发作和癫痫持续状态，给予抗癫痫药物治疗，出现中枢性呼吸衰竭应及时给予辅助通气；不建议常规使用糖皮质激素、免疫球蛋白等，仅在急性脊髓膜炎患者使用免疫抑制剂，吉兰-巴雷综合征推荐使用免疫球蛋白。

2.循环系统。

（1）液体管理

需要静脉补液患者，建议使用晶体液（如林格氏液）进行补液。休克患者，液体补足后组织灌注仍然不良，使用血管活性药物，首选去甲肾上腺素。

（2）心脏支持

卧床休息，保持大便通畅。存在严重心律失常时，予抗心律失常药物治疗。发生心衰时，限制液体入量，予利尿、扩血管等治疗。

3.血液系统。

（1）出血治疗

出血部位明确者，如严重鼻衄给予局部止血，胃肠道出血者给予抑酸药、生长抑素等。血红蛋白低于 60g/L，可输注浓缩红细胞。血小板计数低于 30×10^9/L 伴严重出血者，可输注血小板。

（2）DIC 治疗

适时补充凝血因子、纤维蛋白原和血小板等。

4.严重肝损伤。

予抗炎保肝药物治疗，肝衰竭者可予人工肝等治疗。

（四）中医治疗。

基孔肯雅热属于中医湿温范畴，病因为蚊虫疫毒，发病初期表现为卫分证，部分患者可传入气分或出现卫气同病，核心病机是风邪袭表、湿毒蕴热。

1.辨证分型。

（1）急性期

临床表现：发热，或伴恶风，四肢关节疼痛，可伴有关节肿胀，全身肌肉酸痛，四肢躯干弥漫性红斑或丘疹，或伴瘙

痒，口渴，疲倦乏力。舌淡或淡红，舌苔白腻或黄腻，脉濡滑。

治法：清热化湿，疏风透疹

推荐方药：广藿香 10g、葛根 15g、羌活 10g、滑石 20g、赤芍 10g、淡豆豉 10g、淡竹叶 10g、生地黄 10g、连翘 15g

煎服法：每日 1～2 剂，水煎服，每次 100ml～200ml，每日 2～4 次，口服。儿童剂量酌减，婴儿用 1/3 成人量，幼儿用 1/2 成人量，学龄儿童用 2/3 成人量或成人量。以下处方服法相同（如有特殊情况，须遵医嘱）。

加减法：皮疹瘙痒较重者，加地肤子 10g、荆芥 10g。发热体温超过 38.5℃者，增加中药服用量至每日 2～3 剂，每 4～6 小时服用一次;高热超过 36 小时不退者,加生石膏 30g、香薷 10g；出现高热、狂躁、谵语神昏、四肢抽搐者，予清瘟败毒饮加减，或加用安宫牛黄丸。

（2）恢复期

①湿滞经络证

临床表现：关节疼痛迁延不愈，四肢关节活动不利，或呈游走性疼痛，疲倦乏力，身体沉重。舌淡，苔白或白腻，脉细或濡缓。

治法：除湿蠲痹

推荐方药：羌活 8g、独活 12g、肉桂 3g、秦艽 15g、海风藤 15g、桑枝 15g、当归 10g、川芎 6g、乳香 6g、木香 6g、甘草 6g

②肺脾气虚证

临床表现：疲倦乏力，气短，汗出，胸闷，纳差，胃胀，大便稀溏或黏腻。舌淡，苔白腻，脉细弱。

治法：益气健脾

推荐方药：党参 15g、黄芪 15g、陈皮 10g、茯苓 15g、炒白扁豆 15g、炒麦芽 15g、巴戟天 10g、麦冬 10g、五味子 5g、炙甘草 10g

③肝郁脾虚证

临床表现：心烦，心慌，情绪紧张，口干口苦，失眠，胃胀，纳差。舌淡红，苔少，脉弦细。

治法：疏肝健脾

推荐方药：浮小麦 30g、女贞子 12g、炒酸枣仁 15g、麦冬 10g、茯神 10g、炙甘草 10g、陈皮 5g、炒白扁豆 15g、白芍 15g、山药 15g

2.外治法。

（1）中药沐足

功效：清热祛湿解肌。可改善发热、疲倦、关节痛等不适。

操作方法：广藿香、淡竹叶各 30g，煮水沐足。

（2）放血疗法

功效：泻热解毒，通络止痛。用于高热患者的退热治疗或关节疼痛治疗。

操作方法：高热者于大椎或耳尖点刺放血；关节疼痛者可对关节部位进行放血拔罐。

（3）中药熏洗

功效：化湿通络止痛。可改善关节疼痛。

操作方法：忍冬藤、威灵仙、宽筋藤各 30g，煎煮后取煎汁，纱布浸药，冷敷于疼痛处。

（4）中药湿敷

功效：清热收敛。可改善皮疹瘙痒。

操作方法：黄柏、马齿苋各 30g，煎煮后冷湿敷，每日 2 次。

十、病例发现与报告

医疗机构发现基孔肯雅热疑似病例、临床诊断病例和确诊病例，应于 24 小时内通过“中国疾病预防控制信息系统”进行网络直报。

十一、医院感染控制及解除隔离标准

（一）医院感染控制。

1.疑似、临床诊断和确诊病例急性期须采取防蚊隔离措施，医疗机构应落实防蚊灭蚊措施，病区、医护办公室、值班室安装纱门纱窗，病区内可增设灭蚊灯、蚊香等。患者使用蚊帐。

2.常规检查尽可能在床旁进行，因检查外出病房时，应做好防蚊及环境准备工作。患者外出时，应穿着长袖衣裤，减少皮肤暴露，建议使用防蚊驱避剂。

3.按照标准预防原则做好医院感染控制，接触血液、体液、分泌物、排泄物等要佩戴一次性医用手套，做好手卫生，防止医院感染。患者出院后执行终末消毒，患者使用过的蚊帐用含有效氯消毒剂浸泡、清洗后，方可重复使用。

4.做好医院及周边环境蚊媒孳生地处理，降低蚊密度。

（二）解除隔离标准。

体温恢复正常超过24小时，基孔肯雅病毒核酸检测阴性或病程超过7天者，可以解除隔离。

十二、预防

目前我国尚无可供使用的基孔肯雅病毒疫苗。

预防主要措施包括及时清除蚊虫孳生地，降低蚊媒密度；个人应使用蚊香、驱避剂、蚊帐等方式驱蚊、灭蚊和防蚊；前往基孔肯雅热流行区的旅行者要提高防范意识，防止在境外感染基孔肯雅热。